

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 03	nº 28	01 à 05
Nome do Procedimento: Prevenção de aerossóis				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais que prestam assistência direta ao usuário ou profissionais que realizam atividades junto aos usuários, como também, profissionais em contato com acompanhantes que tiverem proximidade menor de dois metros do usuário, com suspeita ou confirmação de infecção com transmissão por aerossóis				
Objetivo: Reduzir os riscos à saúde ocupacional e à saúde do usuário por meio de propagação de aerossóis, menores que 5µm, eliminado por meio de tosse, espirro ou fala				
Recursos necessários: ✓ Pia com água para lavagem das mãos; ✓ Dispenser de sabão; ✓ Dispenser de papel toalha; ✓ Sabonete ou detergente líquidos; ✓ Papel toalha; ✓ Álcool 70%; ✓ Lixeira com pedal para descarte de material comum; ✓ Lixeira com pedal para descarte de material infectante; ✓ Caixa de descarte para material perfuro cortantes; ✓ Equipamento individual de proteção (EPI): avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, calçado fechado.				

INDICAÇÃO

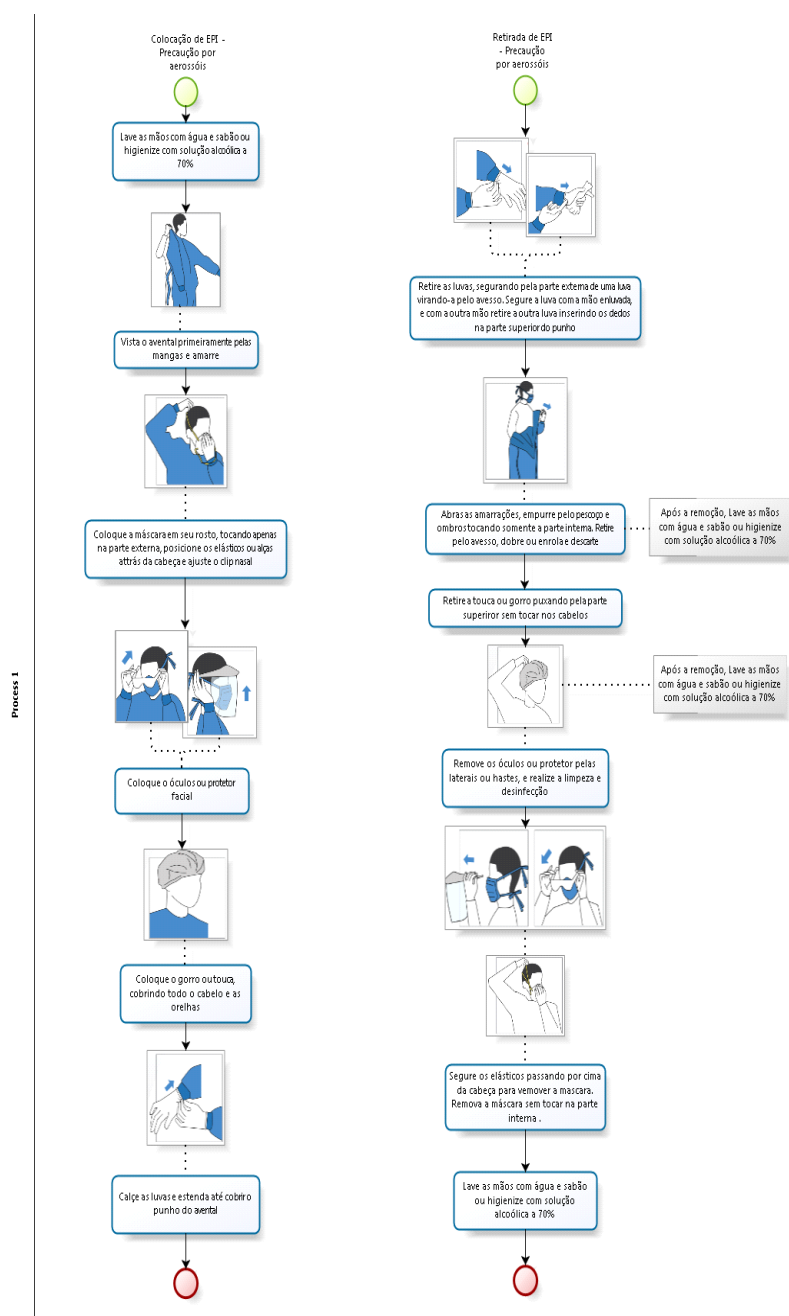
Transmissão de aerossóis por via aérea, por meio de fala, tosse ou espirro. Entre as doenças que possuem esse modo de transmissão estão: influenza, Covid-19 (durante a realização de procedimentos como intubação, aspiração, ventilação não invasiva), sarampo, varicela, tuberculose, hantavírus (Anexo 01).

DESCRIÇÃO

- ✓ **Higienizar as mãos:** lave as mãos com água e sabonete, ou fricção com solução alcoólica a 70%, antes e após o contato com o usuário (POP Rotina 23 – Higienização das Mãos) e após a remoção de EPIS (seguir passos conforme Figura 01);
- ✓ **Avental:** use avental descartável, quando houver risco de contato com sangue e secreções, ou no manuseio de equipamentos ventilatórios e sempre que for realizar procedimentos geradores de aerossol (intubação, ventilação não invasiva, aspiração traqueal). Coloque-o imediatamente antes do contato com usuário ou com as superfícies e retire-os logo após o uso higienizando as mãos em seguida;
 - Certificar-se que o tronco esteja totalmente coberto, incluindo braços e punhos;

- Vista o avental com a abertura para trás.
- ✓ **Máscara PFF2 (N95):** use a máscara PFF2 (N95) durante toda a assistência ao usuário, independentemente do risco de contato com sangue ou secreções, a fim de evitar a inalação de partículas aerossóis (POP Rotina 24 – Recomendações para o Uso da Máscara N95). A máscara deverá estar ajustada à face, impedindo a entrada de ar pelas bordas e laterais, e o clip nasal deve permanecer afixado ao dorso do nariz durante todo o atendimento.
- Realize o teste de aspiração positiva e negativa (vide Nota 1);
- O transporte do usuário deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto;
- Troque de máscara quando estiver úmida ou com sujidade aparente. A mesma máscara deve ser de uso único e poderá ser reutilizada sempre que estiver seca e limpa;
- Não toque na parte interna da máscara, para evitar contaminação interna do material.

Figura 01 – Colocação e retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Máscara N95



Fonte: Anvisa, 2007

Nota 1 – Teste de pressão positiva e negativa

Expire profundamente. Uma pressão positiva dentro da máscara significa que não tem vazamento. Se houver vazamento, ajuste a posição e/ou as alças de tensão. Teste novamente a vedação. Repita os passos até que a máscara esteja vedando corretamente.

A seguir, realize o teste de pressão negativa da vedação, inspirando profundamente. Se não houver vazamento, a pressão negativa fará o respirador agarrar-se no seu rosto. O vazamento resultará em perda da pressão negativa na máscara devido a entrada de ar através de lacunas na vedação;

- ✓ **Óculos ou protetor facial:** use óculos e protetor facial quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.
- ✓ **Gorro:** Use sempre que for prestar a assistência ao paciente em isolamento por aerossóis, vestindo-o antes de entrar no quarto ou unidade do paciente e removendo-o imediatamente ao sair do quarto. O gorro deverá cobrir todo o cabelo e as orelhas. Substituir sempre que apresentar rasgos, sujidade e umidade.
- ✓ **Quarto privativo:** quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o usuário pode ser internado com outros infectados pelo mesmo organismo. A distância mínima entre leitos é um metro. Na ausência de um quarto de isolamento adequado, deixar o usuário próximo a janela (aberta). Ligar o ventilador e desligar o ar condicionado.

Observações:

- ✓ Exceto pela máscara, remova o EPI dentro, ou próximo à saída do quarto ou unidade do paciente. Remova a máscara somente após deixar o quarto do paciente e fechar a porta;
- ✓ Caixa perfuro cortante: descarte, em recipientes apropriados, seringas, agulhas, lâminas e objetos corto contusos, sem desconectá-las ou reencapá-las;
- ✓ Faz-se necessária a utilização de calça ou roupa que cubra as pernas, para proteção contra respingos, resíduos, etc.;
- ✓ Desinfecção de artigos de uso comum: sempre realize assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico (estetoscópio, termômetro, etc.);
- ✓ Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme rotina de limpeza e desinfecção de superfícies (POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície);
- ✓ Desinfecção dos óculos e protetor facial (EPI): após o uso deve ser lavado com água e sabão, não pode ser substituído pelos óculos para correção da visão, com indicação oftálmica, devem ser associados durante o atendimento. No caso da não adaptação dos óculos de correção com os óculos de proteção, preferir o uso do protetor facial.
- ✓ Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIS;
- ✓ Não acumular materiais dentro dos quartos ou à beira do leito, pois esses terão que ser descartados após a saída do paciente;
- ✓ Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme POP Rotina nº 36 – Limpeza e desinfecção de superfície.
- ✓ Além dos EPIS recomendados para precaução de contato e gotículas, profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, devem utilizar a MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO - N95, PFF2 ou equivalente) e GORRO OU TOUCA.
- ✓ Orientações complementares no Vídeo da ANVISA: **Precauções padrão e adicionais**. Disponível no endereço eletrônico: < https://youtu.be/G_tU7nvD5BI >.



Referências

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020**. Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Brasília – SC: 2020.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segurança do Paciente**: Higienização das mãos. Brasília – DF: 2020. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf>. Acessado em: 17 de março de 2020.
3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Cartaz Precauções**. Brasília – DF: 2007. 21/11/2007. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/publicacoes.htm>>. Acessado em: 17 de março de 2020.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde**: volume único. 3ª. ed. Brasília – DF: 2019. 740 p.:il. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf Acessado em: 17 de março de 2020.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2020 Ana Carolina Klein Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil Viviane Karina Korovsky 2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

Wiki da Prefeitura – <https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:Saúde>

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2020	Ana Carolina Klein Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil Viviane Karina Korovsky	
03	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão da Figura 01; • Inclusão da Nota 01; • Inclusão do quadro de observações.



Anexo 01 – Precauções para Aerossóis

Precauções para Aerossóis



Higienização das mãos



Máscara PFF2 (N-95)
(profissional)



Máscara Cirúrgica
(paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Precaução padrão:** higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto.

- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Fonte: Anvisa, 2007.